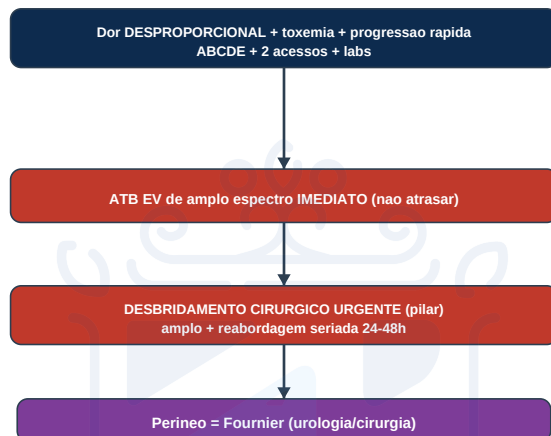


FASCIÍTE NECROTIZANTE — DESBRIDAR JÁ

FLUXOGRAMA — TEMPO É TECIDO

FASCIÍTE — ATB IMEDIATO + DESBRIDAMENTO URGENTE



DEFINIÇÃO E RISCO

EMERGÊNCIA CIRÚRGICA ABSOLUTA

- Infecção (frequentemente polimicrobiana) das fáscias, com progressão RÁPIDA e alta mortalidade se não tratada de imediato
- Na região perineal/genital = síndrome de FOURNIER
- Fatores de risco: diabetes, imunossupressão, alcoolismo, obesidade, DRC, trauma/procedimento local, idade avançada
- Diagnóstico PRIMARIAMENTE CLÍNICO — não aguardar imagem para tratar
- A pele pode parecer pouco alterada nas fases iniciais (a infecção corre pela fáscia)

QUADRO CLÍNICO / RED FLAGS

SUSPEITAR PRECOCEMENTE

- Iniciais: DOR INTENSA e DESPROPORCIONAL ao exame, edema, eritema, febre, mal-estar
- Gravidade: progressão rápida das lesões, CREPITAÇÃO subcutânea, alteração do estado mental
- Instabilidade hemodinâmica, sepse/choque séptico
- Bolhas hemorrágicas, anestesia cutânea e odor fétido são sinais avançados
- A dor desproporcional ao achado cutâneo é a pista mais precoce

MANEJO INICIAL (SIMULTÂNEO)

Rx ABCDE + ATB + CIRURGIA

ABCDE, monitorização, 2 acessos calibrosos, ressuscitação volêmica (protocolo de sepse)
Labs: hemograma, PCR, função renal, eletrólitos, gasometria, lactato, glicemia; hemoculturas (sem atrasar ATB) + urocultura
ATB EV de amplo espectro IMEDIATO cobrindo Gram-positivos, Gram-negativos e anaeróbios:
Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6-8/8h (ou Meropenem 1 g 8/8h); alérgico: Ceftriaxona 2 g/dia + Metronidazol 500 mg 8/8h
± Vancomicina 15 mg/kg 12/12h se suspeita de MRSA (ajustar após culturas)
Acionar URGENTE a cirurgia geral (urologia se Fournier perineal/escrotal)

TRATAMENTO DEFINITIVO

DESTRIDAMENTO É O PILAR

- DESTRIDAMENTO CIRÚRGICO URGENTE, amplo, agressivo e PRECOCE — remover todo tecido desvitalizado
- Reavaliação cirúrgica SÉRIADA (24-48h); frequentemente múltiplas abordagens
- O ATRASO cirúrgico aumenta significativamente a mortalidade
- Suporte intensivo (UTI) para sepse/disfunção orgânica
- Antibiótico é adjuvante — NÃO substitui o destridamento

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos, fator de risco ____ (DM/imunossupressão), com dor desproporcional + ____ (crepitação/necrose); local ____.
- Sinais de sepse/choque ____; lactato ____; sinais vitais ____.
- Condutas: ABCDE, volume, ATB ____ iniciado às ____; hemoculturas.
- Solicito cirurgia URGENTE para destridamento + UTI; transporte com monitorização — NÃO retardar a cirurgia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o pilar do tratamento da fasciíte necrotizante?

- A) Antibiótico isolado por tempo prolongado
- B) Desbridamento cirúrgico urgente, amplo e precoce (com reabordagens seriadas)
- C) Corticoide sistêmico
- D) Oxigenoterapia hiperbárica isolada
- E) Curativos compressivos

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o sinal clínico mais precoce e sugestivo de fasciíte necrotizante?

- A) Eritema discreto indolor
- B) Dor intensa e desproporcional aos achados cutâneos
- C) Prurido
- D) Descamação seca
- E) Hipotermia isolada

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Como se denomina a fasciíte necrotizante de localização perineal/genital?

- A) Síndrome de Mirizzi
- B) Síndrome de Fournier
- C) Síndrome de Lemierre
- D) Síndrome de Ogilvie
- E) Síndrome de Boerhaave

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a antibioticoterapia na fasciíte necrotizante, é correto:

- A) Substitui o desbridamento cirúrgico
- B) Deve ser de amplo espectro, iniciada imediatamente, cobrindo Gram-positivos, Gram-negativos e anaeróbios, sem substituir a cirurgia
- C) Só deve ser iniciada após o resultado das culturas
- D) Deve ser via oral
- E) Não é necessária

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que o diagnóstico de fasciíte necrotizante não deve aguardar exames de imagem?

- A) Porque a imagem é sempre normal
- B) Porque é um diagnóstico primariamente CLÍNICO e o atraso cirúrgico aumenta a mortalidade
- C) Porque a imagem é contraindicada
- D) Porque não há tratamento
- E) Porque a doença é benigna

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O pilar é o desbridamento cirúrgico urgente, amplo e precoce, com reabordagens seriadas (24-48h); o atraso aumenta muito a mortalidade. ATB e suporte são adjuvantes.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A dor intensa e desproporcional aos achados cutâneos é o sinal mais precoce e sugestivo — a pele pode parecer pouco alterada porque a infecção corre pela fáscia.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A fasciíte necrotizante perineal/genital é a síndrome de Fournier, que exige desbridamento urgente e frequentemente avaliação da urologia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O ATB deve ser de amplo espectro, imediato, cobrindo Gram-positivos, Gram-negativos e anaeróbios ($\pm$ vancomicina se MRSA), mas NÃO substitui o desbridamento cirúrgico.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

É diagnóstico primariamente clínico; não se deve aguardar imagem, pois o atraso no desbridamento aumenta significativamente a mortalidade.

SM24
Suporte ao Plantão Médico